

✦ Пространство новых идей 2.0

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ · МИНТРУД РОССИИ

Не просто накормить

Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими нарушениями в домах социального обслуживания

Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года · директора и специалисты учреждений из 51 региона

Докладчик: Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“» · доклад: 284 стр., 121 источник, 22 кейса, 45 приложений

Презентация — маршрут по докладу: вопросы, цифры, инструменты. Каждый слайд указывает на раздел, где всё разобрано.

Два вопроса — и одна просьба на весь доклад

Вопрос 1. Поднимите руку: в вашем учреждении жители выбирают блюдо из двух вариантов?

Вопрос 2. Кто за последние полгода замерял отходы за семь дней подряд?

Теперь посмотрите на зал: **здесь сидят минимум четыре организации, где выбор уже работает** — Успенский и Болотнинский ПНИ, Усть-Илимск, «Серафимовский». И один регион, где модель масштабирована решением области, — Иркутская область.

Значит, дальше мы говорим не о гипотезе, а о практике, которая физически в этом зале.

Просьба на весь доклад: каждый вопрос залу — это инструмент из доклада. Помечайте мысленно, какие из них уже есть у вас, а какие — заберёте с собой.

174 000 человек едят трижды в день по чужому решению

174 000

человек живут в стационарных организациях
социального обслуживания

139 500

из них — жители психоневрологических интернатов

51 регион — участники семинара · **41 регион** переименовал ПНИ в дома социального обслуживания · **7 000** человек уже перешли
в сопровождаемое проживание — и им понадобился навык, который тренируется за столом

Еда — единственная услуга, которую система оказывает каждому жителю три-четыре раза в день, каждый день.

Ни одна другая зона не даёт столько ежедневных контактов с человеком — и столько возможностей для ошибки.
Доклад, раздел 23 — система ПНИ-2026 в числах

Один обед — пять конфликтов. И ни один из них — не про повара

01

Очередь против помощи.

Кто ест сам — уже с холодным. Кому нужна помощь — ждёт: четыре сиделки на двенадцать кормимых.

02

«Он опять не ест кашу».

Третий день подряд — и никто не связал это с началом дисфагии. Логопеда в штате нет.

03

Кофе и клозапин.

Две кружки крепкого кофе от родственников — и вечером «плохой день». Кухня об этом не знает.

04

Вторая котлета.

«Вам нельзя, вы полнеете» — хотя ограничение рациона никто не назначал. Сиделка решила за врача.

05

«Приведите журналы в порядок». Накануне комиссии. Самое опасное из пяти — имитация контроля.

Среднего жителя не существует

За одним столом — пять осей неоднородности. Каждая меняет то, как человек ест и как его надо спрашивать.

Психическое состояние

Депрессия — «безразличие к еде», тревога — избегание столовой, психоз — подозрительность к пище. Волнообразно.

Когнитивные функции

От сохранного интеллекта до глубокой деменции. Статус определяет инструмент выбора — а не его наличие.

Коммуникация

Неговорящие — значимая доля контингента. Вопрос «что будете?» для них — худший из инструментов.

Соматика

Дисфагия, диабет, клозапиновые запоры, эпилепсия. Ограничения, внутри которых должен жить выбор.

Опыт и культура

«Всю жизнь ужинал в девять», религиозные правила, праздничные блюда как якоря идентичности.

Пять чисел директора

Сколько едят сами · с помощью · неговорящих · в группе дисфагического риска · на весогенных препаратах.

Одна тарелка — шесть измерений. Провал любого — недоедание или конфликт

1

Достаточность — порция, выданная и не съеденная, достаточностью не является

2

Безопасность — санитарная, клиническая (текстуры), поведенческая (пика)

3

Удовольствие — невкусная еда съедается хуже: вкус — фактор потребления

4

Социальность — общий стол персонала и жителей: бесплатный мониторинг «он сегодня не жуёт»

5

Самостоятельность — навык, который потом нужен в сопровождаемом проживании

6

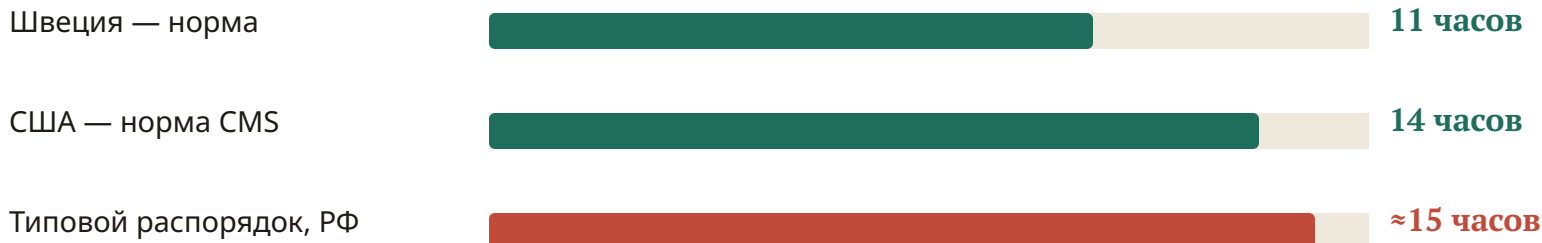
Выбор — единственное измерение, которое нельзя делегировать системе

Каждое измерение проверяется за десять минут, без рубля:

- безопасность — постоять у линии и посмотреть, кто из списка риска ест вне поля зрения смены;
- физиология — сверить ужин и завтрак с часами; · психология — спросить вечером «что сегодня было на обед»;

· социальность — ест ли персонал вместе с жителями; · право — проверка реальности выбора; · экономика —
ЗАМЕР №1 · НОЧНОЙ ИНТЕРВАЛ
сырьевая строка за минуту деления.

Сколько часов житель не ест: от ужина до завтрака



Ужин в 17:30, завтрак в 8:30 — пятнадцать часов без еды. **Это не экзотика, а типовой график.** Для жителей на антипсихотиках голодная ночь — путь к ночным набегам на кухню и к чужим тарелкам.

Вопрос залу: какая цифра в вашем доме — от последней подачи ужина до первого завтрака?

Замер занимает три дня и не требует ни рубля. Обычно реальный интервал отличается от графика на бумаге.

Бесплатные меры: поздний перекус по списку с врачом · сдвиг ужина внутри существующего распорядка · контроль фактического времени подачи

Доклад, разделы 6 и 13.4 · нормы: шведские и американские протоколы (реестр практик); значение РФ — оценка по типовым графикам

Четыре числа, которые делают тему стола клинической

21,9–69,5 %

жителей с расстройством глотания — по разным исследованиям. Нижняя граница: **каждый пятый**. Логопеда в типовом ПНИ нет.

×7

смертность от пневмонии при тяжёлых психических расстройствах против популяционной. Аспирация — главный смертельный риск стола.

Всё это — измеримо и управляемо организацией стола: текстуры, мониторинг веса, журналы, ночная конструкция. Организация питания — часть профилактики преждевременной смертности.

Доклад, разделы 9–14 · источники: реестры MEDICAL_EVIDENCE и INTERNATIONAL_PRACTICES

+3,01 кг

максимальная прибавка веса за **шесть недель** терапии антипсихотиками (мета-анализ 100 РКИ). Прибавка $\geq 7\%$ у 76 % на клозапине.

4–30 %

жителей с ночным едением. На отделении в 30 человек — **от одного до девяти** человек каждую ночь.

Правовая рамка уже существует — её не нужно «пробивать»

ЗЕЛЁНАЯ · можно сразу

- Питание ≥ 3 раз в день, диетическое по показаниям — СанПиН, п. 56 подп. 11–14
- **Число вариантов блюда ничем не ограничено** — только безопасность и периодичность
- Права получателя и учёт индивидуальных потребностей — ст. 9, 16 442-ФЗ
- Гуманное отношение и достоинство — ст. 37/43 Закона № 3185-1
- Таблицы замен продуктов — законный механизм эквивалентной

замены

Доклад, раздел 17 — зелёная, жёлтая и красная зоны

ЖЁЛТАЯ · через процедуру

- Положение о вариативном питании + согласование с учредителем
- Лечебное питание — назначение врача поимённо, со сроком пересмотра
- Ограничения рациона и текстуры — только врач
- Изменение продуктовой строки и штатов — учредитель
- Аутсорсинг — отдельный контракт с восемью строками

КРАСНАЯ · нельзя никогда

- Принудительное кормление и насилие за столом
- Ограничение рациона «по представлению сиделки»
- Имитация контроля: журналы «под комиссию», пробы задним числом — ст. 6.6 КоАП
- Пищевые карты как открытые персональные данные
- «Согласие недееспособного» в формулировках без правовой проверки

СанПиН — про безопасность, а не про однообразие

СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Действует до 01.09.2026. Питание не менее 3 раз в день, диетическое по показаниям, контроль на всех этапах — пробы, бракераж, температура, питьевой режим.



СанПиН 2.3/2.4.4282-26

С 01.09.2026 (пост. № 18 от 02.06.2026). Тот же каркас: питание ≥ 3 раз в день, диетическое по показаниям, суточные пробы от каждой партии блюда — п. 56 подп. 11–14.

Главное: ни одна из редакций не ограничивает число вариантов блюда. Вариативность входит в санитарный контур целиком — каждый вариант защищён теми же процедурами, что и мономеню.

После 1 сентября локальные акты и чек-листы перепривязываются к пунктам 4282-26 — модель выбора при этом не меняется.

Два технических следствия для двух вариантов: суточная проба — с каждого блюда (обеих гастрорёмокостей); маркировка вариантов — цветом, чтобы раздающий не перепутал.

Температура контролируется на линии и на последнем столе — на обеих ёмкостях.
Доклад, раздел 18 — санитария при вариативности

74 % недееспособны — но выбор блюда не сделка

74 %

жителей ПНИ признаны недееспособными.
Признание означает опеку над сделками — но
не отменяет бытовых предпочтений.

Ст. 29 ГК РФ — сделки совершает опекун. Выбор
каши — не сделка.

Закон требует учитывать мнение недееспособного
в вопросах, затрагивающих его интересы.
Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 КПИ —
поддержанное решение, а не подмена.

Слово — по меню, по картинке, доступным языком

Показ — две порции перед глазами: выбор указанием, жестом,
взглядом

Наблюдение — что доедается, а что отодвигается: устойчивый
паттерн потребления

Биография — пищевая история человека, когда спросить уже
некого

Между мономеню и полным выбором — не пропасть, а лестница

Каждая ступень — работающая модель с известной ценой. Вопрос не «вводить ли», а «какая ступень нам по силам в этом году».

0

Мономеню + замена при отказе. Житель не остаётся голодным. Фундамент.

1

Два варианта в одной позиции (завтрак/обед, часть дней). Болотнино.

2

Выбор по всем позициям ежедневно. Успенский ПНИ, модель Иркутской области.

3

Выбор на линии раздачи («шведский стол») — выборочно: салаты, напитки, десерты.

4

Семейная подача за столом — точно, где рассадка позволяет.

5

«Своя кухня» — горизонт сопровождаемого проживания.

Ступени 0–2 — подтверждённая российская практика · 3–5 — горизонт, а не массовая модель

Ступень определяется вчерашним днём, а не положением: был ли второй вариант физически на линии вчера? Зафиксирован ли вчерашний выбор в журнале? Есть ли житель, получивший вчера не то, что ему принесли бы по умолчанию?

Четыре учреждения уже это сделали — без специальных бюджетов

Болотнинский ПНИ · Новосибирская область, с 2024

Выбор из двух на завтрак и обеде, несколько раз в неделю. Перечень пар определяет диетсестра. Ступень 1.

Успенский ПНИ · Новосибирская область, с 2024

Два вторых, два салата, два напитка — ежедневно, все отделения. «Страхи не подтвердились». Ступень 2.

Усть-Илимский дом социального обслуживания · Иркутская область, с сентября 2024

Начали с опроса предпочтений жителей. Ступень 1–2.

ДСО «Серафимовский» · Санкт-Петербург, 2025

Дом докладчика. Назвал и цену перехода: полное масштабирование требует оборудования и ставок — честно, без прикрас.

Иркутская область — единственный регион, масштабировавший модель решением области (S018)

В девяти системах выбор в питании — нормативный мейнстрим

Заимствуем только проверяемые нормы — числа и процедуры. Без «лучших систем»: сравниваем механизмы, а не страны.

Великобритания — предпочтения по времени, месту и количеству еды (CQC Reg 14)

Австралия — «что, когда, где и как я ем» как самостоятельный стандарт

Онтарио — решётка измеримых норм: помощь 1:2, триггеры веса

США — альтернатива при отказе, ночной интервал 14 ч, F-теги

Скандинавия — ночной интервал 11 ч, совместный стол персонала

Германия / Австрия — биография питания, конец «диабетического стола»

Япония — надбавка за специалиста
→ обязательная норма

Финляндия — совместные трапезы как элемент качества

Нидерланды — семейная подача: качество жизни и потребление энергии

Урок Японии для нас: норма о питании выросла из логики дефицита — сначала деньги за специалиста (2005), через 16 лет обязательность (2021), параллельно национальная база данных. Структурированная поддержка питания: госпитализации 20,3 % против 30,6 %.

Два варианта — это вторая гастроёмкость и тетрадь, а не вторая кухня

Вариант Б — из той же заготовки, в том же потоке. Три фильтра: эквивалентность, совместимость с потоком, предсказуемость спроса.

Крупы: гречка / рис / пшено / овсянка — полностью взаимозаменяемы по таблицам

Вторые: котлета / тефтели · тушёное / печёночный соус · рыба / биточки — одна заготовка, две формы

Салаты: свекольный / морковный · капустный / винегрет

Напитки: чай / какао / кофейный напиток — с учётом клонзапинового правила (кофеиновая строка карты)

Первые: борщ / щи · суп крупяной / суп овощной — при готовности к двум котлам

Чего в парах не должно быть: «гречка или что осталось» — это не выбор, а недо-вариант

Цена ступени 1: сырьё не растёт — перераспределение внутри той же строки. На 30 человек второй вариант каши — это +3–4 кг крупы в сутки при том же суммарном расходе.

Самый частый сбой вариативности — «вариант Б закончился». Лечится тетрадью

1 **Заказ накануне.** Вчерашний выбор определяет сегодняшние объёмы варки

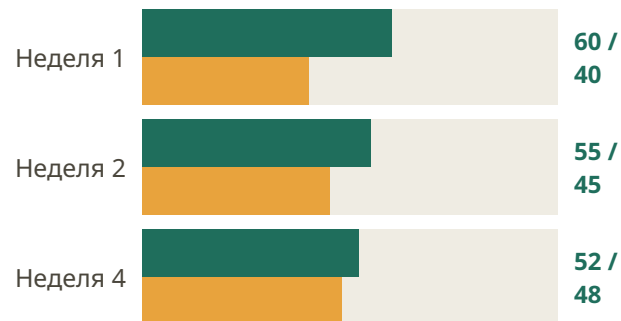
2 **Старт 50/50 с резервом.** Через 2–3 месяца статистика стабилизируется

3 **Пересчёт раз в две недели.** Доля выбравших Б корректирует закупку

4 **Индикатор сбоя:** «выбрал Б — не получил Б» стремится к нулю. Если растёт — проблема в объёмах, а не в жителях

Пропорции заказов стабилизируются (иллюстративный пример)

% заказов по неделям



Заказ невербальных жителей формируется из пищевых карт и вчерашнего показа — та же тетрадь, другой источник.

Четыре правила, которые обязана знать кухня

Клозапин ↔ кофеин.

Резкий рост кофеина поднимает концентрацию препарата. Правило: считать чашки — включая какао и

ИМАО ↔ тирамин.

Выдержанные сыры, копчёности — риск гипертонического криза. Правило: тираминовая разметка меню

Литий ↔ соль и вода.

Резкие изменения соли и питьевого режима — риск интоксикации. Правило: стабильность, а не запрет.

Грейпфрут ↔ психотропные.

Рост концентрации препаратов до ~40 %. Правило: исключить по списку.

Одна таблица на посту — бесплатная мера безопасности.

Кухня не лечит — но она обязана знать, какие продукты конфликтуют с назначениями, и отмечать их в пищевой карте. Семью жителя на клозапине предупреждают: передачи тоже считаются.

Дисфагия — скрытая эпидемия стационарного стола

каждый

пятый

минимум — таковы исследования распространённости расстройства глотания. В типовом ПНИ нет ни логопеда, ни скрининга: дисфагия невидима до первой тяжёлой пневмонии.

Шесть признаков, видимых без инструментов:

кашель при еде

«мокрый» голос после глотка

долгое пережёвывание без глотания

скопление пищи за щекой

подтекание изо рта

повторные пневмонии в анамнезе

Любой признак → запись → врач. Это выучивается сменой за один

IDDSI — международная шкала текстур: 8 уровней с тестами вилкой и наклоном. Внедрение в пяти учреждениях подняло соответствие текстур назначенным с 44 % до 90 %, жидкостей — с 31 % до 100 %.

Программа начинается не с блендера, а с обучения смены. Назначение текстуры — решение врача, с пересмотром.

Вес — две строки, а не одна: набор и потеря

Иначе кухня «скринит истощение», глядя на прибавку. Категорию риска ставит врач — кухня даёт вес и факт поедания.

Набор: метаболический риск

Антипсихотики дают прибавку в разы: $\geq 7\%$ массы — у 76 % на клозапине, 37 % на оланзапине. **Триггер: +5 % за 3 месяца → врач сегодня.**

Потеря: недостаточность питания

Скрининг MUST (BAPEN): ИМТ + непреднамеренная потеря $>5\%$ за 3–6 месяцев. Пороги Онтарио: $\geq 5\%$ за 30 дней / $\geq 7,5\%$ за 90 / $\geq 10\%$ за 180 → сигнал врачу.

Механика мониторинга — нулевой стоимости: взвешивание раз в месяц, одни и те же весы, одно и то же время, запись в карту.

Кто заполняет MUST в ПНИ: медсестра или врач по инструкции инструмента, ежемесячно. Кухня ставит вес и факт поедания — категорию риска не ставит никто, кроме обученного.

«Посадить на диету» — только врач. Ограничительный рацион по запросу жителя или семьи — тоже врачебное решение.

Ночные набеги на кухню: не замок, а конструкция

Ночное едение — у 4–30 % жителей: препаратная гиперфагия, нарушение сна-аппетита, тревога. Замок на кухне не работает: голодный житель конфликтует и ищет еду вне дома. **На 30 человек — это от одного до девяти жителей каждую ночь.**

Перечень

2–3 продукта с врачом: кефир, хлеб, фрукты. Для метаболического риска — низкокалорийные объёмные варианты.

Место

Точка выдачи на посту или буфетная зона отделения. Не кухня — санитарно и организационно.

Режим

Фиксированное окно 21:00–22:00 и по запросу при пробуждении. Запись в журнал.

Границы

Жителям с гиперфагией — порционные объёмы, а не «возьми сам». Вода и чай — всегда.

Двойной смысл конструкции: клинический — ночное едение перестаёт быть подпольным; правовой — еда ночью перестаёт быть «нарушением режима» и становится предусмотренной услугой.

Одна и та же мера закрывает две задачи: поведенческую (меньше набегов и конфликтов) и нормативную (ночной интервал ужин—завтрак сокращается до разумного).

Линия важнее меню: четыре принципа раздачи

Поток

Заказ накануне убирает выбор из очереди. Визуальное меню до линии, маркировка вариантов, направление потока — так, чтобы не создать пробку и не остудить тарелку.

Помощь

Еда подаётся под готовую помощь, а не до неё. Ориентир: не более двух полностью кормимых на одного работника. Кто ест сам — не ждёт, пока накормят других.

Видимость

«Почему ему больше?» — конфликт, который рождается на глазах. Порции на линии видны, добавка регламентирована, выбор одного не ущемляет другого.

Атмосфера

Раздача — как сервис, а не как выдача. Персонал за общим столом: это бесплатный мониторинг «он сегодня не жуёт» и тепло вместо конвейера.

Честная цена вариативности: замер, а не обещание

Мы не утверждаем, что вариативность «почти бесплатна». Мы утверждаем: цена определяется замером — до старта и через 90 дней.

Модель	Что меняется	Сырьё / труд	Разовые затраты
М1. Выбор из двух (завтрак+обед, 2–3 дня в неделю)	Вторая гастрорёмкость, журнал заказа	≈0 — перераспределение пар · +минуты на линии	Гастрорёмкости, маркеры
М2. Выбор ежедневно по позициям	Тот же принцип в полном объёме	≈0 при пересчёте по статистике · +время учёта	Визуальное меню
М3. Буфетная зона (салаты, напитки)	Самообслуживание в зоне	Рост потребления → пересчёт · контроль зоны	Стеллажи, посуда
М4. Семейная подача (точно)	Подача общими блюдами	≈0 · меняется роль персонала	Столовая посуда
М5. «Своя кухня» (реабилитация)	Программа навыков	Как у группы · персонал-сопровождающий	Кухонная зона

Ключевой механизм М1–М2: сырьё не добавляется — перераспределяется внутри той же строки через пары эквивалентов. Модельные оценки, не замеры: ваша цифра — после семи дней замера.

Отходы — единственная честная «экономия» выбора

Иллюстративный расчёт · дом на 150 жителей:

**80 г остатков × 3 приёма × 150 =
36 кг в день
≈ 9 000 ₽ в день**

при условной цене 250 ₽/кг. Цифры условные — порядок действий настоящий.

Логика проста: несъеденная порция — оплаченное сырьё в мусорном ведре. Выбор снижает долю несъеденного, потому что нелюбимые блюда перестают попадать на тарелку.

Но доказательной базы эффекта в наших условиях нет. Поэтому формула доклада — замер до и после: семь дней до пилота и семь дней через 90.

Как замер превращается в рубли: три веса в день — выдано, возвращено с тарелок, остатки кухни · топ-3 блюд по остаткам сверяются с циклом · масса недельных отходов × закупочная цена килограмма = ваша строка «выброшенных денег».

Два диагноза: тарелочные остатки — про вкус и порцию; кухонные — про планирование объёмов. Снижение после выбора — гипотеза, которую подтверждает только повторный замер.

Вариативность — это документы, а не только блюда

Без комплекта та же практика выглядит для проверяющего как отступление от раскладки. С комплектом — как система.

Главный правовой риск директора — не внедрение выбора, а отсутствие документов при уже существующей практике.

Положение о вариативном питании — локальный акт: что, для кого, кто отвечает

Меню с вариантами — пары эквивалентов внутри норм и раскладок

Журнал заказа — выбор накануне и пересчёт объёмов

Журнал замен — отказ обернулся альтернативой, а не голодом

Пищевые карты жителей — ограничения, текстуры, кофеиновая строка

Согласование с учредителем — письменный разговор наверх

Честная учётная запись: журналы ведутся в день события, а не «по памяти вечером». Суточные пробы — с каждого блюда, включая оба варианта.

Документальная имитация контроля — состав дел по ст. 6.6 КоАП. Настоящие журналы — ваша защита: они показывают систему, а не «причёрсанную» неделю.

Доклад, раздел 31 — документальный комплект: шесть базовых документов

Проверяющий спросит — отвечайте документом

«Почему два варианта?»

Ответ: положение о вариативном питании + таблицы замен продуктов. Варианты — эквиваленты внутри нормы, а не «что попало».

«Где пробы второго блюда?»

Ответ: суточные пробы с каждого блюда — обе гастроёмкости, обе строки журнала. Температура — на обеих ёмкостях, на линии и на последнем столе.

«Кто назначил диету?»

Ответ: врач, поимённо, со сроком пересмотра — список в пищевых картах. Ограничений «по представлению сиделки» нет и не будет.

Страх проверки лечится комплектом, а не отказом от практики. Три типовых вопроса и три документальных ответа разобраны в разделе 32.

И главное правило: **не говорить проверяющему того, чего нет в документах.** Если журнал ведётся с сегодняшнего дня — так и сказано; «привести в порядок» задним числом — это уже имитация контроля.

Кухня не своя — вариативность живёт в восьми строках контракта

Без своей плиты директор не «добавляет вторую кастрюлю» — он меняет спецификацию. Если контракт уже идёт — пилот начинается с допсоглашения и приёмки, не с линии.

- минимум два варианта в точке приёма пищи — в спецификации

- объёмы по журналу заказа, а не «средний расход»

- альтернатива при отказе — в регламенте замен

- суточные пробы с каждого блюда — в приёмке

- маркировка вариантов и текстур — клинический элемент

- журнал срывов и замен — общий, а не «их»

- температура на линии и последнем столе — в приёмке

- ответственность за срыв — санкции по контракту

Честно: публичных кейсов вариативности именно на аутсорсинге в открытых источниках нет — это пробел доклада, а не доказательство невозможности. Осенний календарь закупки (раздел 42.7) важнее любого слайда.

Пилот за 90 дней: одно отделение, без новой сметы

«Без новой сметы» не значит «без затрат» — это значит: сначала замер, документы и обучение, потом выбор на линии.

Дни 1–14 · подготовка

Семидневный замер отходов и отказов · пять чисел о контингенте · пары эквивалентов · положение и журналы · инструктаж смены.

На линии — ничего не меняется.

Дни 15–75 · пилот на линии

Одно типовое отделение. Выбор из двух на завтрак и обеде — старт 50/50 с резервом. Журнал заказа каждый день, срыв «вариант Б закончился» — записывается, а не прячется. Роли: диетсестра — пары, повар — поток, старшая смена — контроль «вариант Б существует».

Дни 76–90 · оценка

Повторный семидневный замер. Сравнение до/после: отходы, отказы, время раздачи, доля выбравших. Решение: масштабировать, скорректировать или остановить — по числам.

Критерии остановки существуют заранее: рост отказов от еды, срывы подачи чаще заданного, жалобы семьи, негативная динамика веса в группе риска. Пилот, который «не пошёл», — это данные, а не поражение.

Масштаб первого пилота — меньше значит быстрее: одна позиция, один приём, одно отделение.

Двенадцать месяцев: от пилота к системе

Квартал 1 · фундамент

Месяцы 1–3: замер, пять чисел контингента, документы, лекарственно-пищевая таблица на пост, журнал отказов, список дисфагического риска. Безопасный фундамент.

Квартал 2 · горизонталь

Месяцы 4–6: пилот выбора в одном отделении, вторая позиция, салаты и напитки. Журнал заказа и пересчёт объёмов по статистике.

Квартал 3 · структура

Месяцы 7–9: совет жителей, панель чисел директора, обучение по трём уровням, ротация ответственных. Практика переживает смену людей.

Квартал 4 · масштаб

Месяцы 10–12: весь дом, заслушивание у учредителя по панели чисел, письменный разговор наверх, третий замер через 90 дней.

Как карта умирает: уходит инициатор → процедура «временно» упрощается → через квартал журнал ведётся «для проверки», а выбор снова делает кухня. Внешне организация остаётся «внедрившей».

Признаки регресса в числах: падает доля выбирающих, растёт доля «стандартных», журнал срывов пустеет — не потому что срывов нет. Противоядие одно: приказ, ротация ответственных, квартальная панель.

Четырнадцать возражений — и что с ними делать

Каждое разобрано в разделе 37 без издёвки — в большинстве есть рациональное ядро. Здесь — три главных ответа:

«Не способны выбирать» · «Будут очереди» · «Это дорого» · «Санэпид не разрешит» · «Нет диетолога» · «Выберут нездоровое» · «Выбрал и отказался» · «Лечебное питание» · «Персонал против» · «Проверка спросит» · «У нас 400 мест» · «И так нормально» · «Кухня не своя» · «Через 4 дня новый СанПиН»

Двенадцать из четырнадцати

снимаются **документами, замерами или конструкцией линии:**

положение, журнал заказа, пары эквивалентов, инструктаж смены.
«Зачем, если и так нормально?» — снимается только собственными числами замера.

Тринадцатое — «кухня не своя»

снимается **спецификацией, а не энтузиазмом:** восемь строк контракта, допсоглашение, приёмка. Если контракт впереди — осенний календарь закупки важнее любого слайда.

Четырнадцатое — «новый СанПиН»

снимается **чек-листом 1 сентября, а не паузой:** 4282-26 не запрещает число вариантов; журналы августа не переписываются; проверка в сентябре смотрит сентябрь по новым правилам.

Вопрос залу: какое возражение — ваше? Поднимите руку — и после семинара возьмите готовый ответ из раздела 37.

А сами бы вы так ели?

Тридцать дней одного и того же завтрака. Без выбора. Без права отказаться — «каприз». С холодной тарелкой, потому что вас кормят последним.

Это не риторика — это критерий проверки любого решения. Если ответ «нет» — начинайте с замера. Если «да» — тогда замер всё равно покажет, где вы ошибаетесь.

Через четыре дня — новый СанПиН. План на утро 1 сентября

Новые формы бракеража

Открываются с утра, привязанные к пунктам 4282-26 (п. 56 подп. 11–14). Журналы августа не переписываются — август смотрится по старым правилам.

Локальные акты — на новые пункты

Положение о питании, чек-листы пищеблока, ППК — перепривязка к 4282-26. Модель выбора при этом не меняется: обе редакции её допускают.

Суточные пробы — с каждого блюда

При двух вариантах — обе гастроёмкости, обе строки журнала. Ошибка «проба только с основного» для проверяющего — отсутствие пробы второго блюда.

Проверка в сентябре

Смотрит сентябрь по новым правилам и август по старым. Останавливать выбор «пока привыкнем» — лишняя работа: обе редакции выбор допускают.

Переходного периода нет — и он не нужен: СанПиН 4282-26 не запрещает число вариантов блюда, он меняет формы контроля.

Чек-лист «1 сентября» — в приложении 39 доклада: утром открываете новые формы, вечером закрываете **первый день по новым правилам.**

От объекта заботы к соавтору меню: совет жителей

Три модели участия — от информирования к соавторству. Каждая законна; разница — в том, чей голос слышен.

1 · Информирование

Меню вывешено, жители знают, что будет. Голос — в ящике пожеланий. Это не участие, но честный первый шаг.

2 · Консультация

Опрос предпочтений (опыт Усть-Илимска), разбор остатков, ежемесячная встреча с кухней. Мнение влияет на цикл меню.

3 · Соавторство

Совет жителей участвует в формировании циклов, пробует новые блюда, видит журнал замен. Формат — особый, с сопровождением.

Недееспособные жители в совете — не исключение, а особый формат: сопровождение, доступный язык, право не участвовать. Совет декоративный — хуже, чем никакого: он имитирует голос.

Конфликт интересов «учреждение = опекун» решается процедурой: решения совета фиксируются, разбираются на квартальной панели, в спорных вопросах — запрос учредителю.

Вернёмся к обеду: у каждого конфликта теперь есть процедура

Конфликт из обеда	Процедура	Раздел доклада
Очередь против помощи	Норма помощи 1:2 (ориентир), подача под готовую помощь, порядок заходов	20, 28
«Он опять не ест кашу»	Журнал отказов, правило «три отказа → врач в тот же день», шесть признаков дисфагии	10, 12
Кофе и клозапин	Лекарственно-пищевая таблица на посту, предупреждение семьи о передачах	11
Вторая котлета	Ограничение рациона — только врач; выбор из пары эквивалентов вместо «можно/нельзя»	13, 17, 19
Журналы «в порядок»	Комплект документов, честная учётная запись, квартальная панель чисел	31, 33

Доклад не обещает, что конфликты исчезнут. Он показывает, что они перестают быть безымянными. Теперь у каждого — имя, процедура и человек, который отвечает.

Что изменится для четырёх человек

Житель

Еда перестаёт быть тем, что с ним происходит. Он называет, показывает, выбирает, отказывается — и отказ не превращается в голод: есть задокументированная альтернатива.

Сиделка

«Покормить» заменяется понятной работой с опорными точками: карта жителя, таблица текстур, правило трёх отказов. Вместо вины — процедура.

Директор

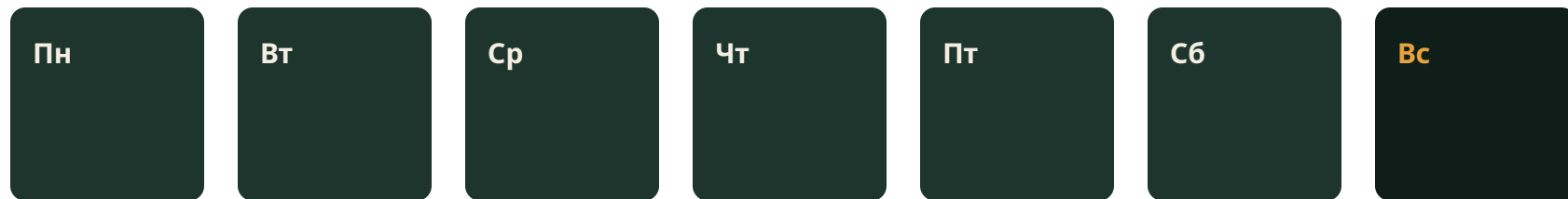
Тема питания выходит из зоны тревожного тумана «придут — спросят» в зону управляемой системы: приказ, журналы, панель чисел, дата заслушивания у учредителя.

Учредитель

Появляется работа, которую может сделать только он: статусы норм, «мост» к лечебному питанию, показатели отрасли. И цифры вместо жалоб.

Семь дней замера отделяют убеждение от знания

Понедельник, 8:30. Ничьих разрешений не нужно. Форма — приложение 25 доклада.



Три веса в день: **выдано** · **возвращено с тарелок** · **остатки кухни**. Плюс отказы с эскалацией и фактическое время раздачи. Построчно, не одной суммой: «сколько жителей оставляют больше трети порции», а не «сколько в среднем оставляют».

Что бы замер ни показал — дальше у вас будет не мнение о питании в вашем доме, а знание о нём.

Из этого знания растёт всё остальное: пилот, совет жителей, разговор с учредителем, а через год — возможно, ваш рассказ на таком же семинаре. Третий рассказ внедривших, которому зал поверит: за ним

Через год возможны два сценария

Сценарий А · Полка

Вы вернулись, положили доклад на полку — «сложная тема, но когда-нибудь». Ничего не изменилось, кроме одного: теперь вы знаете, что у коллег работает. И каждая жалоба на еду читается иначе.

Сценарий Б · Система

Неделя замера, совет, пилот в одном отделении. Панель чисел лежит у учредителя. Два варианта второго — обычный день, который уже никто не замечает, как не замечают водопровод.

Разница между сценариями — не деньги (пилот дешевле одного ремонтного дня), **не разрешения** (замеры не требуют согласований), **не люди** (смена та же). Разница — первая неделя. Первая неделя дешевле года сомнений.

Человек за столом ждёт не доклада. Он ждёт обеда, в котором есть место его выбору.

Теперь вы знаете, как такой обед организовать. Всё остальное — в докладе: 284 страницы, 121 источник, 22 кейса, 45 приложений.

Три шага на выходе из зала:

замер — семь дней · пара — на линии или в подносе · строка — в положении о питании и в спецификации контракта

Спасибо. Продолжение — за вашей линией раздачи, в ближайший понедельник, 8:30.